

TURP — 经尿道前列腺电切术（TURP）

患者须知 · 治疗前列腺增大的经典标准手术

WARWIKI

TURP 是治疗良性前列腺增生（BPH）导致排尿梗阻的常用成熟手术。医生经尿道置入内镜，无需体表切口，用电切环切除压迫尿道的前列腺内层组织，从而显著改善尿流，疗效持久，已有数十年的临床验证。

关于这项手术

医生将细长器械（**电切镜**）经尿道置入。用小型电切环逐块切除阻塞内层的前列腺组织，扩宽排尿通道。前列腺外层保持原位。术后放置导尿管，待局部愈合后拔除。

安全吗？

TURP 是研究最充分的泌尿外科手术之一，疗效显著。与所有手术一样，存在出血、感染、短期刺激等风险，以及一些预期的长期影响（见下文）。该手术最适合**中等大小**的前列腺；腺体极大者可能更适合 HoLEP（钬激光前列腺剝除术）、Aquablation 或开放前列腺切除术。

名词解释

TURP

经尿道前列腺电切术——治疗 BPH 的内镜手术。

BPH

良性（非癌性）前列腺增生。

电切镜

手术中用于修剪前列腺的内镜器械。

逆行射精

精液逆流入膀胱——常见且无害的术后改变。

导尿管

术后引流膀胱的管道，留置约 1–3 天。

膀胱冲洗

术后早期经导尿管轻柔冲洗，清除血液。

术后会有哪些变化？ 大多数男性排尿明显增强。最常见的长期改变是**逆行射精**——精液逆流入膀胱，性高潮感觉正常，但射出的精液极少甚至没有。这对健康无害（但会影响生育力）。勃起功能或尿控严重受损的情况较少见。

如何准备

- 手术在**脊椎麻醉或全身麻醉**下进行——遵医嘱禁食并调整用药（按要求停用抗凝药）。
- 术前需进行**尿液检查**，排除感染。
- 安排人接送；术后需留置导尿管数天，提前做好准备。

过程及术后

- 1 麻醉后，给予预防性抗生素。
- 2 经内镜切除阻塞的前列腺组织。
- 3 留置导尿管，第一天有时进行轻柔膀胱冲洗。
- 4 通常住院一晚；**1–3 天后**拔除导尿管。

术后数周内可能出现**尿液带血**及轻度烧灼感、尿急；请多饮水，避免用力和重体力劳动。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 拔除导尿管后**无法排尿**
- **大量出血或血块**堵塞尿流
- 发热或寒战
- 出血加重（术后 1–2 周少量出血较常见——休息多饮水即可）

需要记住的三件事

1. TURP 经内镜切除阻塞的前列腺内层组织，无需切口——是治疗中等大小 BPH 的经典高效标准手术。
2. 术后排尿明显改善；最常见的长期改变是逆行射精（无害）。
3. 尿液带血和刺激症状通常在数周内消退。如出现无法排尿、大量出血或发热，请及时就医。